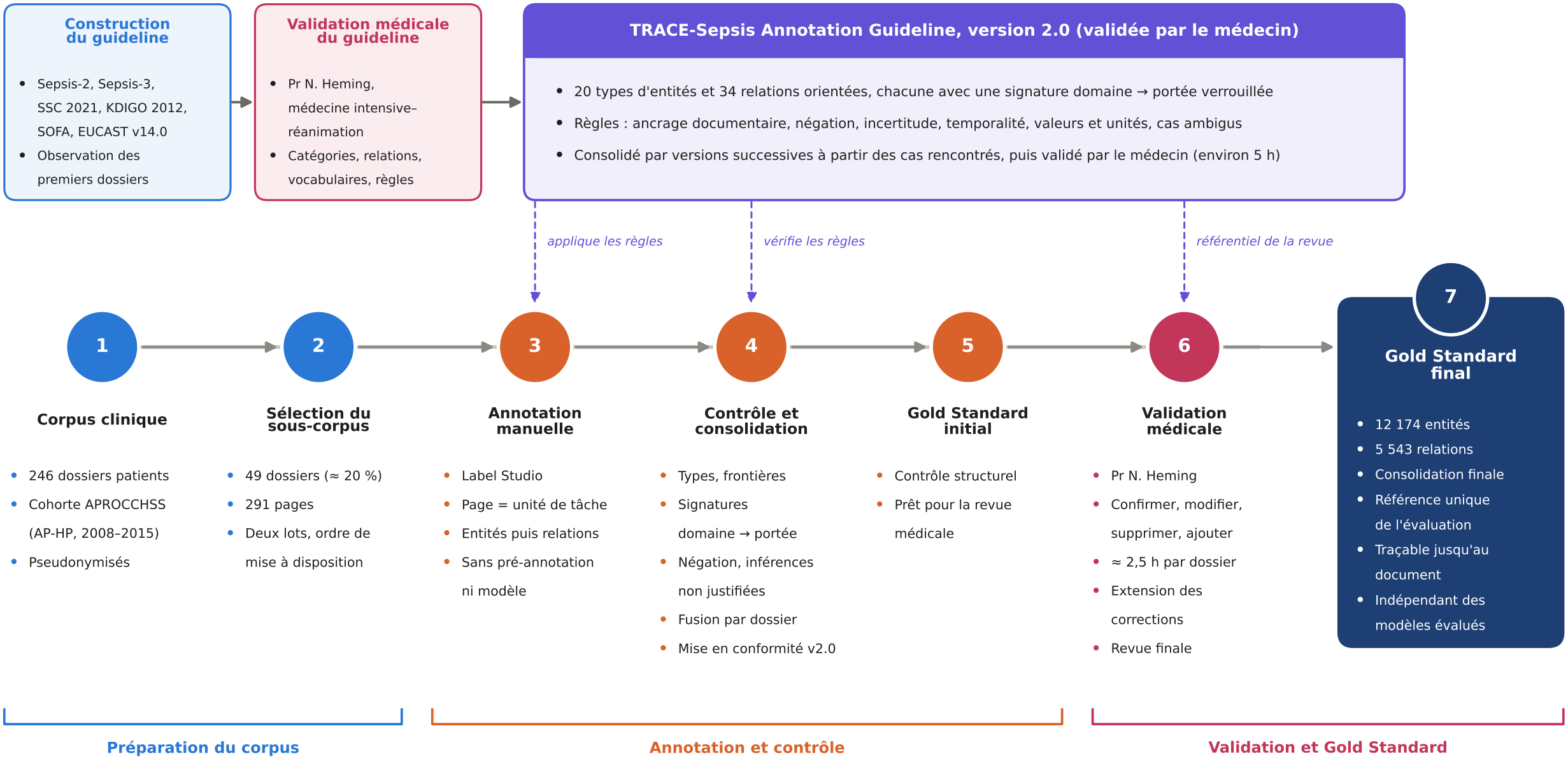

Construction du guideline
Sepsis-2, Sepsis-3, SSC 2021, KDIGO 2012, SOFA, EUCAST v14.0
Observation des premiers dossiers
Validation médicale du guideline
Pr N. Heming, médecine intensive–réanimation
Catégories, relations, vocabulaires, règles
TRACE-Sepsis Annotation Guideline, version 2.0 (validée par le médecin)
20 types d'entités et 34 relations orientées, chacune avec une signature domaine → portée verrouillée
Règles : ancrage documentaire, négation, incertitude, temporalité, valeurs et unités, cas ambigus
Consolidé par versions successives à partir des cas rencontrés, puis validé par le médecin (environ 5 h)
applique les règles
vérifie les règles
référentiel de la revue
1
Corpus clinique
246 dossiers patients
Cohorte APROCCHSS (AP-HP, 2008–2015)
Pseudonymisés
2
Sélection du sous-corpus
49 dossiers (≈ 20 %)
291 pages
Deux lots, ordre de mise à disposition
3
Annotation manuelle
Label Studio
Page = unité de tâche
Entités puis relations
Sans pré-annotation ni modèle
4
Contrôle et consolidation
Types, frontières
Signatures domaine → portée
Négation, inférences non justifiées
Fusion par dossier
Mise en conformité v2.0
5
Gold Standard initial
Contrôle structurel
Prêt pour la revue médicale
6
Validation médicale
Pr N. Heming
Confirmer, modifier, supprimer, ajouter
≈ 2,5 h par dossier
Extension des corrections
Revue finale
7
Gold Standard final
12 174 entités
5 543 relations
Consolidation finale
Référence unique de l'évaluation
Traçable jusqu'au document
Indépendant des modèles évalués
Préparation du corpus
Annotation et contrôle
Validation et Gold Standard